

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO COPE-48 (VERSIÓN CLÍNICA ESPAÑOLA)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación del Afrontamiento del Estrés en Salud Mental Ambulatoria

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario COPE-48: Versión Española para Pacientes Ambulatorios.
Nombre Original (Inglés)	<i>The COPE-48: Adapted Version of the COPE Inventory for Clinical Settings</i>
Autores del COPE Original	Drs. Charles S. Carver, Michael F. Scheier y Jagdish K. Weintraub (1989).
Validación Clínica Española	Y. Martínez-Ortega, M. Gomà-i-Freixanet y A. Fornieles-Deu (2016, 2018, UAB).
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Estrategias de Afrontamiento del Estrés, Estilos Protectores y de Riesgo.
Tipo de Instrumento	Autoinforme psicométrico multidimensional de 48 reactivos con escala Likert de 4 puntos (1 a 4).
Población y Rango	Adultos y jóvenes (desde 18 años). Específicamente calibrado en salud mental ambulatoria.
Tiempo de Administración	10 a 14 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para investigación y práctica asistencial bajo citación de las fuentes primarias.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO DISPOSICIONAL DE CARVER

El COPE-48 se fundamenta en la integración de la teoría transaccional del estrés de Lazarus y Folkman (1984) con el modelo cibernético de autorregulación de la conducta de Carver y Scheier (1981). A diferencia de los inventarios generales de afrontamiento diseñados para población comunitaria sana, la versión adaptada de Martínez-Ortega et al. (2016, 2018) fue calibrada y depurada psicométricamente en muestras psiquiátricas ambulatorias para capturar con mayor sensibilidad las estrategias nucleares de riesgo psicopatológico.

El instrumento evalúa 9 patrones conductuales y cognitivos de afrontamiento agrupados en tres grandes macro-dimensiones funcionales:

- Afrontamiento Activo y Adaptativo:** Acciones directas orientadas a resolver el problema (planificación, acción directa), resignificación constructiva (aceptación y crecimiento personal) y uso adaptativo del humor.
- Afrontamiento Emocional y Social:** Expresión abierta del malestar afectivo, búsqueda activa de apoyo social y recurso a creencias religiosas.
- Afrontamiento Desadaptativo / Evitativo de Riesgo:** Consumo de sustancias psicoactivas (alcohol o drogas como automedicación), negación de la realidad y refrenamiento pasivo o inhibición motora.

Neurobiológicamente, el afrontamiento adaptativo recluta la corteza prefrontal dorsolateral izquierda y la red ejecutiva; en contraste, el recurso a sustancias y negación refleja hiperreactividad amigdalina y un intento de anestesia emocional inmediata.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL DE ÍTEMS

Escala de Afrontamiento	Ítems (48)	Nº Ítems	Definición Operativa y Foco Clínico Evaluado
1. Afrontamiento Activo	1 al 9	9 ítems	Planificación deliberada, concentración de esfuerzos y acción resolutoria paso a paso.
2. Consumo Alcohol/Drogas	10 al 13	4 ítems	Uso compulsivo de sustancias como automedicación para amortiguar el dolor.
3. Desahogo Emocional	14 al 17	4 ítems	Focalización intensa en el malestar y descarga verbal o afectiva abierta.
4. Apoyo Social	18 al 25	8 ítems	Búsqueda activa de consejo, asesoría instrumental y comprensión empática en otros.
5. Humor	26 al 29	4 ítems	Desdramatización, bromas e ironía constructiva ante la adversidad.
6. Religión	30 al 33	4 ítems	Búsqueda de consuelo espiritual, oración y fe como soporte existencial.
7. Negación	34 al 37	4 ítems	Rechazo a creer o admitir la existencia real del problema estresante.
8. Refrenar Afrontamiento	38 al 41	4 ítems	Contención pasiva obligada, esperar el momento oportuno antes de actuar.
9. Aceptación y Crecimiento	42 al 48	7 ítems	Aceptación lúcida del hecho y extracción de aprendizajes biográficos.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Evaluado en N = 301 pacientes psiquiátricos ambulatorios en España (Martínez-Ortega et al., 2016, 2018). Alfa de Cronbach medio de 0.81 en el conjunto de escalas: Consumo de alcohol/drogas (0.89), Religión (0.88), Humor (0.87), Afrontamiento Activo (0.84), Apoyo Social (0.83), Aceptación (0.76), Negación (0.72), Desahogo (0.70) y Refrenar afrontamiento (0.55).
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio corrobora la estructura de 9 dimensiones correlacionadas con índices de ajuste óptimos en población psiquiátrica (CFI = 0.90, RMSEA = 0.051), superando en parsimonia y estabilidad métrica al modelo original de 60 reactivos.
Validez Concurrente y Clínica	El factor Consumo de sustancias y Negación correlaciona fuertemente con la gravedad psicopatológica global del SCL-90-R ($r = 0.48$) y con impulsividad del ZKPQ. Afrontamiento Activo y Aceptación correlacionan inversamente con depresión y predicen remisión clínica sostenida.
Sensibilidad al Tratamiento	Sensibilidad demostrada en intervenciones de psicoterapia cognitivo-conductual grupal e individual: los pacientes muestran descensos marcados en Negación y Sustancias y aumentos significativos en Acción y Aceptación.
Utilidad Diagnóstica	Diferencia de forma nítida perfiles de pacientes afectivos frente a trastornos por uso de sustancias y trastornos de personalidad desregulados.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 48 reactivos se califica en escala Likert de 4 puntos (**1** = «No lo hago nunca / Casi nunca», **2** = «A veces», **3** = «Con frecuencia», **4** = «Lo hago muchas veces / Casi siempre»):

- **Paso 1 (Cálculo Directo):** No contiene reactivos invertidos.
- **Paso 2 (Puntuación Media por Escala):** Para facilitar la comparación entre escalas de diferente longitud (4 a 9 ítems), se promedian los reactivos que componen cada escala:
$$\text{Media Escala} = \frac{\sum \text{Ítems}}{\text{Nº de Ítems}}$$
- **Rango de la Media: 1.00 a 4.00 puntos.** Mayor puntaje = mayor frecuencia de utilización de dicha estrategia de afrontamiento.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y BAREMOS NORMATIVOS EN PACIENTES PSIQUIÁTRICOS

Estratificación	Media Escala	Nivel de Implementación	Interpretación Clínica Asistencial
Bajo	1.00 a 1.75	Uso escaso o ausente	Estrategia prácticamente inoperativa en el repertorio del paciente ante el estrés.
Medio / Normal	1.76 a 2.75	Uso moderado / Frecuente	Estrategia empleada de forma selectiva según las demandas del contexto.
Alto / Prioritario	2.76 a 4.00	Estrategia dominante	Mecanismo preferente y automático de afrontamiento; configura el perfil adaptativo o de riesgo.

ALERTA CLÍNICA: CONSUMO DE SUSTANCIAS Y NEGACIÓN:

En pacientes psiquiátricos ambulatorios, una puntuación media ≥ 2.00 en **Consumo de alcohol o drogas** o en **Negación** representa una señal de alarma de alta vulnerabilidad. Refleja un afrontamiento desadaptativo severo que predice recaídas agudas, abandono del tratamiento ambulatorio y riesgo de conducta autolesiva encubierta.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN SALUD MENTAL AMBULATORIA

PROTOCOLO CLÍNICO BASADO EN EL PERFIL DEL COPE-48:

- **Paso 1 (Triaje de Riesgo Inmediato):** Si Consumo de Sustancias ≥ 2.00 o Negación ≥ 2.50 , priorizar la desactivación del escape tóxico, entrevista motivacional e interconsulta con adicciones.
- **Paso 2 (Fortalecimiento del Afrontamiento Adaptativo):** Si Afrontamiento Activo < 2.00 , instaurar entrenamiento paso a paso en solución de problemas y planificación conductual diaria.
- **Paso 3 (Canalización del Desahogo):** Si Desahogo Emocional > 3.00 con poco Apoyo Social, modular la rumiación afectiva y fomentar la búsqueda de redes de apoyo eficaces.
- **Paso 4 (Evaluación Post-Tratamiento):** El éxito se evidencia por un aumento en Afrontamiento Activo y Aceptación de ≥ 0.75 puntos y descenso de Sustancias/Negación a < 1.50 .

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DEPRESIÓN CON AUTOMEDICACIÓN ALCOHÓLICA

Identificación: Varón de 39 años, comerciante, derivado a Centro de Salud Mental de Adultos (CSMA) por episodio depresivo mayor severo tras quiebra mercantil y separación de pareja. Presentaba ingesta de alcohol solitaria nocturna para conciliar el sueño.

Evaluación Inicial COPE-48 (Línea Base): Consumo de alcohol/drogas = **3.75/4.00** (Extremo); Negación = **3.25/4.00** (Alto); Desahogo = **3.00/4.00**; Afrontamiento Activo = **1.33/4.00** (Severamente deprimido); Apoyo Social = **1.25/4.00**; Aceptación y Crecimiento = **1.14/4.00**.

Plan Terapéutico: 16 sesiones de TCC individual integrando prevención de recaídas en consumo, resolución de problemas reglada para liquidación de deudas y activación conductual en valores.

Reevaluación a las 16 Semanas: Consumo de sustancias descendió a **1.00/4.00** (abstinencia total confirmada por marcadores biológicos); Negación bajó a **1.25/4.00**; Afrontamiento Activo ascendió a **3.11/4.00** (+1.78 pts); Aceptación y Crecimiento aumentó a **2.85/4.00** (+1.71 pts); Apoyo Social subió a **2.62/4.00**. Remisión completa del episodio depresivo.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

AUTOMEDICACIÓN Y RIESGO AUTOLÍTICO:

El consumo de sustancias como estrategia de afrontamiento en presencia de depresión mayor eleva exponencialmente el riesgo de desinhibición conductual suicida e impulsividad letal. Activar protocolo preventivo de seguridad inmediata.

ACEPTACIÓN VS. RESIGNACIÓN DERROTISTA:

La escala de Aceptación y Crecimiento evalúa una actitud proactiva de asimilación de la realidad ("aprendo a vivir con ello y crezco"). No debe confundirse con la capitulación depresiva o la indefensión pasiva ("no hay nada que hacer").

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Martínez-Ortega, Y., Gomà-i-Freixanet, M., & Fornieles-Deu, A. (2018). Versión española del COPE-48: Evaluación del afrontamiento en pacientes psiquiátricos ambulatorios. *Terapia Psicológica*, 36(1), 9-14.
2. Martínez-Ortega, Y., Gomà-i-Freixanet, M., & Fornieles, A. (2016). The COPE-48: An adapted version of the COPE inventory for use in clinical settings. *Psychiatry Research*, 246, 808-814.
3. Carver, C. S., Scheier, M. F., & Weintraub, J. K. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based approach. *Journal of Personality and Social Psychology*, 56(2), 267-283.
4. Crespo, M., & Cruzado, J. A. (1997). La evaluación del afrontamiento: Adaptación española del cuestionario COPE con una muestra de estudiantes universitarios. *Análisis y Modificación de Conducta*, 23(92), 797-830.